



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : عيبر جمال حسين حسن

المحافظة : جنوب سيناء الحي / المدينة : طور سيناء

رقم البطاقة : 28207272200423 رقم التليفون : 01013686665

العمر (تاريخ الميلاد) : 27-07-1982 المهنة : حاصل علي دبلوم

العنوان : 4ال720وحده

تاريخ تسجيل الإستمارة : 10-10-2026

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

خطاب إداري

هذا الرقم القومي يتبع منظومة التأمين الصحي الشامل جهة الاختصاص



--

Name: عبير جمال حسين حسن National ID: 28207272200423	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

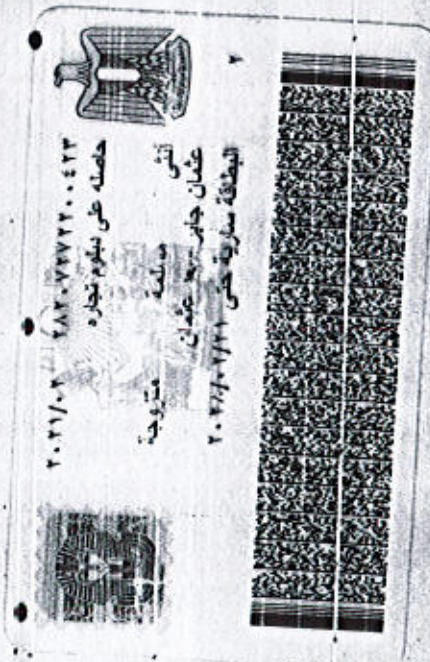
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



ارجاء عفوونها
 ارجاء عفوونها
 ارجاء عفوونها

مركز الأورام
NASSER INSTITUTE
ONCOLOGY CENTER

معهد ناصر
مركز الأورام



NUCLEAR MEDICINE UNIT

وحدة الطب النووي

Patient Name: Abeer Gamal
Referring physician: Prof.

Date: 10/12/2020

^{99m}Tc-MDP BONE SCAN

Desired information : skeletal surveying to detect multiple lesions.

Technique: Anterior and posterior whole body scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc-MDP:

Report:

- No definite hot spot that account for osseous deposits could be detected all over the surveyed skeleton.
- Degenertaive changes are noted in the dorso-lumbar vertebrae.
- Both kidneys are normally seen

Conclusion:

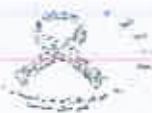
- No definite evidence of metatstatic osseous deposits.

Thanks for reference

Nuclear Medicine Unit

Magdy Kotb, M.D.

Name:	عبير جمال حسين حسن	
MR. :	3645	
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient underwent right modified radical mastectomy with reconstruction on 12/02/2020 for a right breast carcinoma staged as pT2N2M0 (4 of 16 lymph nodes positive). Pathology demonstrated estrogen receptor positivity in 7 of 8 cores, progesterone receptor negativity (0/8), and HER2 negativity. The patient completed adjuvant chemotherapy consisting of four cycles of doxorubicin and cyclophosphamide followed by four cycles of a taxane (4 AC → 4 T) and subsequently received postoperative radiation therapy. Since December 2020, the patient has been on ovarian function suppression with Zoladex combined with the aromatase inhibitor Arimidex for three months, with ongoing endocrine therapy. A bone scan performed on 18/04/2026 revealed an equivocal active osseous lesion in the left supra-orbital region. The plan is to follow this finding after three months while continuing Arimidex plus supplemental therapy for three months. The patient is a 43-year-old premenopausal female with right breast cancer (ER 7/8, PR 0/8, HER2-). After completing the aforementioned surgery, adjuvant chemotherapy, and radiation, she has been receiving Zoladex and Arimidex since December 2020. The recommendation is to discontinue Zoladex now that she has completed more than five years of ovarian function suppression, and to check serum estradiol and FSH after stopping ovarian suppression, repeating these labs every three months until menopausal status is confirmed. If ovarian function recovers (premenopausal), the aromatase inhibitor should be stopped and tamoxifen initiated to complete extended endocrine therapy; if the patient becomes postmenopausal, continuation of letrozole (Femara) as extended endocrine therapy is advised. A brain CT performed in August 2026 was negative for disease. The patient will continue Arimidex plus supplemental therapy for three months, and the next follow-up visit is scheduled for 28/11/2026.		
تحريراً في ,		
	الوقت :	التاريخ : 18-09-2026
	dina makram	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		



Pathology Report

Name: عبيد جمال حسين

Age: 55 years.

Clinical data: Right breast mass.

Specimen type: wide local excision , axillary clearance, wedge resection from nipple

Date: 12/2/2020

Lab. Number: 247

Hospital Number: 2019 / مبادرة

Gross Description:

Three specimens were received:

- 1) Right breast mass excision; a fibro-fatty tissue piece; 5.5x4x2 cm. Cut sections revealed an ill-defined greyish white rubbery to firm mass; 5x4x2 cm.
- 2) Axillary clearance measured; 6x4 cm, enclosing; 16 nodules, up to 1.5 cm.
- 3) Nipple wedge biopsy; a greyish white tissue piece; 1x0.5 cm, totally submitted.

Microscopic Examination:

Histopathological examination of sections prepared from the lumpectomy specimen received reveals an infiltrating malignant epithelial growth. The tumour is made up of groups and small sheets of pleomorphic hyperchromatic malignant ductal epithelial cells with micropapillary features. Stromal desmoplasia is moderate. Cellular and nuclear atypia are moderate. Intraduct component is 15% comedo and non comedo. Scattered lymphovascular emboli. No perineural invasion.

Surgical margins are free.

LN 4/16 with no extranodal extension.

Nipple shows paget's disease.

Diagnosis:

- Invasive duct carcinoma GII, with micro-papillary features.
- In situ comedo, non-comedo 15%.
- No perineural invasion.
- Positive lymphovascular.
- Free surgical margins.
- Lymph nodes 4/16 with no extranodal extension.
- Nipple, paget's disease of the nipple.
- Stage pT2 pN2a.

Prof. Dr. Lubna Omar

Doc No. 12345